

Conversion AMI (feuille sans trad)

1. Cas 1

Validation Cs : Oui

A JEUN Commentaire : a jeun 6h avt op solides et 2h avt op liquides clairs

alcool : Occasionnel

allergies : Non Connue

Score Apfel/Vpop : 3

Appareil auditif : Normal

Asa : 1

Atcd intubation difficile : Non

ATCD VAM difficile : Non

BMI : 19,17

Allergènes : RAS

Clinique : RAS

Date intervention : 25/01/202X

Date_Coag : 06/12/2022

Diagnostic : IOA sur PTH

DTM : Oui

estomac plein : Non

Etat dentaire : Bridge sup droit/Pas de dents mobiles

état veineux D : Bon

état veineux G : Bon

Geste opératoire : Membre inférieur (Lavage articulaire (hanche/Gauche))

HDLM : A glissé sur une plaque de verglas.

Autonome sur tous les plans, parker 9.

désunion cicatrice et écoulement a 1 mopis avec hémoc +

a cocci +

PCR covid neg

heure intervention : 07:30

Informations Consentements : Technique d'Analgésie, Technique
d'Anesthésie, Intubation, Risque Anesthésie, ALR

Modalité : 1/2 urgente

Intervenant : Dr XXX

Lee : 0

Lentilles contact : Non

Mallampati : 1

Mécanisme IM : ????

Médecin Sénior : Pr XXX

Morsure lèvre supérieure : NE

ouverture de bouche : Oui

piercing : Non

poids : 42,0

post-opératoire : SSPI

Prieur : NE

Rachis cervical : Oui

rgo : Non

RP : Normale

Scanner/Echo : ???

sevrage alcool : Non

sevrage tabac : Non

sevrage toxicomanie : Non

tabac : Non

taille : 148

Terrain : RAS

Transfusion : Non

type d'anesthésie : AG

type intubation : IOT

VAM obésité : Non

VAM ronflement : Oui

VAM barbe : Non

VAM édentation : Non
VAM âge>55 ans : Oui
PIT : 41,50
PC : 41,7127
CSA_sevrage_vapote : Non
CSA_tatouage : ?
CSA_sevrage_tabac : Non
CSA_sevrage_alcool : Non
score iot : 0
score iot NE : 2
score vam NE : 0
Commentaire_iot_vam : cormack 1 en 2022
score vam adulte : 2
BNP (2) : 76
C.R.P. (2) : 4.6
Coagulation (2) : Normal
Coeur : auscultation (2) : Souffle systolique Ao - BDC réguliers
Coeur : signes fonctionnels (2 : Aucun - Met > 4 - Rando 10-20 km hebdo
Créatinine (2) : 55
E.C.G. : Normal
E.F.R. (2) : ???
Fibrine : 3.6
Hémoglobine (2) : 13.7
INR : 1
K+ (2) : 4
Leucocytes (2) : 14
Na (2) : 141
Péricarde : ???
Plaquettes : 307
Poumon : auscultation (2) : Normale
Poumon : signes fonctionnels (: Aucun

Prélevement nez : ???

Protides (2) : 69

Rx pulmonaire (2) : ???

Sinus : ???

T.C.A. : 0.91

T.P. : 100

test allen droit : ???

test allen gauche : ???

Urée : 5

Antibioprofylaxie : poursuite cloxa

CISAI = supressif

Préméd J-1 : lovenox 0.2

Bilan complémentaire : verifier groupe/RAI

Commentaires Remarques : Explication AG et ALR, patiente ok

Sexe féminin : Oui

Non fumeur : Oui

ATCD de NVPO : Non

Analésie morphinique : Oui

texte asa : 1. Patient en bonne santé.

2. Patient présentant une atteinte modérée d'une grande fonction.

3. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction
qui n'entraine pas d'incapacité.

4. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction,
invalidante, et qui met en jeu le pronostic vital.

5. Patient moribond, dont l'espérance de vie est inférieure à 24
heures, avec ou sans chirurgie.

Chirurgie à haut risque : Non

Cardiopathie ischémique : Non

ATCD insuf card congestive : Non

ATCD d'AVC : Non

DID : Non

Créatinine>20.mg/DL(152ùM) : Non

medoc1 : Lovenox 0.4

: cloxacilline

poso2 : 2gx6/j

arret1 : Non

arret2 : Non

arret3 : Non

arret4 : Non

arret5 : Non

traitement : Non

CPT : inutile

GroupeRh : 1ère et 2ème DTER à faire

Pfc : non

Plaquette : Aucune

RAI : Extension à 21 jours possible

sc11 : 0

sc21 : 0

sc31 : 0

sc41 : 0

sc51 : 0

sc61 : 0

sc71 : 0

ne11 : 0

ne21 : 0

ne31 : 0

ne41 : 0

ne51	: 0
ne61	: 1
ne71	: 1
sc13	: 0
sc23	: 0
sc33	: 1
sc43	: 0
sc53	: 0
sc63	: 1
ne13	: 0
ne23	: 0
ne33	: 0
ne43	: 0
ne53	: 0
ne63	: 0

2- Cas 2

Validation Cs : Oui

A JEUN Commentaire : stop aliùmentation : ITV H-6

STOP boissons claires : ITV H*2

alcool : Non

allergies : Non Connue

année sevrage alcool : 2013

Score Apfel/Vpop : 1

Appareil auditif : Appareil bilatéral

Asa : 3

Atcd intubation difficile : ?

ATCD VAM difficile : ?

BMI : 28,07

Allergènes : RAS

Clinique : RAS

Commentaires intubation : ck 1 2019

Date intervention : 10/0X/202X

Date_ionogramme : 05/04/2023

Date_Plaquettes : 05/04/2023

DTM : > 65 mm

estomac plein : Non

Etat dentaire : Prothèse Haut/Bas/pas de mobilités dentaires

état veineux D : Bon

état veineux G : Difficile

Fc : 78

Geste opératoire : chirurgie pariétale (Eventration [avec plaque])

heure intervention : 12:30

Informations Consentements : Technique d'Analgésie, Technique
d'Anesthésie, Transfusion, Intubation, Risque
Anesthésie, Risque Post-op, Risque Transfusion

Modalité : Réglée

Intervenant : Dr DOUSSOT A.

Intubation difficile ? : Non

Lee : 1

Lentilles contact : Non

Mallampati : 1

Mecanisme IM : ????

Médecin Sénior : : Dr X

Morsure lèvre supérieure : Oui

ouverture de bouche : > 35 mm

PA : 135/82

piercing : Non

poids : 84,0

post-opératoire : Réanimation

Prieur : Non

Rachis cervical : souple
rgo : Non
RP : Normale
SaO2 : 99
Scanner/Echo : ???
VAM : 3
sevrage alcool : Oui
sevrage tabac : Non
sevrage toxicomanie : Non
tabac : Non
taille : 173
Terrain : RAS
Transfusion : Non
type d'anesthésie : AG
type intubation : IOT
VAM obésité : Oui
VAM ronflement : Non
VAM barbe : Non
VAM édentation : Oui
VAM âge>55 ans : Oui
Ventilation difficile : Non
PIT : 68,75
PC : 75,3052
CSA_sevrage_vapote : Non
CSA_tatouage : ?
CSA_sevrage_tabac : Non
CSA_sevrage_alcool : Non
Autres Examens :
Cavités droites (2) : Normales
Clairance créatinine (2) : 47
Coeur : auscultation (2) : souffle systolique connu

Coeur : signes fonctionnels (2 : met sup 4 - pas de sf thoracique

CRE (2) : 26/04/2023

Ventricule gauche non dilaté avec une fonction contractile segmentaire et globale normale.

FEVG à 59 %. Débit cardiaque calculé à 6,6 l/min.

Aorte normale.

Valve aortique calcifiée . Rétrécissement aortique non serré. Gradient moyen VG-Ao à 19

mmHg. Insuffisance aortique minime (grade 1/4).

Valve mitrale normale. Absence d'insuffisance mitrale.

Oreillette gauche non dilatée.

Oreillette droite normale. Ventricule droit normal.

Absence d'HTAP. Valve tricuspide normale.

Insuffisance tricuspide minime (grade 1/4).

Absence d'épanchement péricardique.

Créatinine (2) : 132

E.C.G. : A faire - A voir

E.F.R. (2) : ???

F.E. (2) : 67,00

Fonction systol (2) : conservée

Hémoglobine (2) : 14.1

HTAP (2) : NON

HVG (2) : Non

K+ (2) : 4.8

Leucocytes (2) : 5600

Na (2) : 138

Echo cardiaque : Oui

Péricarde : Péricarde sec

Plaquettes : 160000

Poumon : auscultation (2) : Normale

Poumon : signes fonctionnels (: Aucun

Prélevement nez : ???

Rx pulmonaire (2) : ???

Sinus : ???

test allen droit : ???

test allen gauche : ???

texte libre Appareils : G15 orienté

Vit maritale

autonome à domicile

Urée : 7.0

Valve Aortique (2) : Normale

Valve mitrale (2) : Normale

VEMS % (2) : 104

VEMS ml (2) : 3040

VG (2) : Non dilaté

Conclusion : pas de syndrome restrictif

franche amélioration de la membrane alvéolo capillaire
avec DLCO corrigée à 81%

test de marche ne retrouve pas de désaturation

--> amélioration clinique et fonctionnelle post

pneumopathie COVID

Antibioprophylaxie : céfu 1.5g

Préméd J-1 : surveillance dextro

protocole insuline

cellcept 500 2/0/2

crestor 10 0-0-1

pantoprazole 40 0/0/1

phosphoneuros 40 gouttes

Préméd J0 : cellcept 500 2/0/2

phosphoneuros 40 gouttes

advagraf 1.5 1/0/0

surveillance dextro

protocole insuline

Prescription : Bas de Contention

Commentaires Remarques : proposition théorique de péridurale thoracique, mais je redemande au chirurgien si il y a une indication sur l'éventration.

Pas dispo ajd, à revoir ultérieurement,

patient OK surle principe, coag à vérifier

Sexe féminin : Non

Non fumeur : Oui

ATCD de NVPO : Non

Analgésie morphinique : Non

texte asa : 1. Patient en bonne santé.

2. Patient présentant une atteinte modérée d'une grande fonction.

3. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction
qui n'entraîne pas d'incapacité.

4. Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction,
invalidante, et qui met en jeu le pronostic vital.

5. Patient moribond, dont l'espérance de vie est inférieure à 24
heures, avec ou sans chirurgie.

Chirurgie à haut risque : Non

Cardiopathie ischémique : Non

ATCD insuf card congestive : Non

ATCD d'AVC : Non

DID : Oui

Créatinine>20.mg/DL(152µM) : Non

medoc1 : cellcept 500

poso1	: 2/0/2
	: metformine 500
poso2	: 1-0-1
medoc3	: crestor 10
poso3	: 0-0-1
medoc4	: kardegic 75
poso4	: 0/1/0
medoc5	: pantoprazole 40
poso5	: 0/0/1
medoc6	: kenzen 4
poso6	: 1/0/0
medoc7	: phosphoneuros 40
poso7	: 1/1/1
medoc8	: advagraf 1.5
poso8	: 1/0/0
medoc9	: novonorm 1mg
poso9	: 1/0/0
arret1	: Non
arret2	: Non
arret3	: Non
arret4	: Non
arret5	: Non
traitement	: Oui
CPT	: inutile
GroupeRh	: 1ère et 2ème DTER conformes
nb PFC	: 0
nbr CGR	: 0
nbr plaquettes	: 0
Pfc	: non
Plaquette	: Aucune
RAI	: A faire à l'entrée